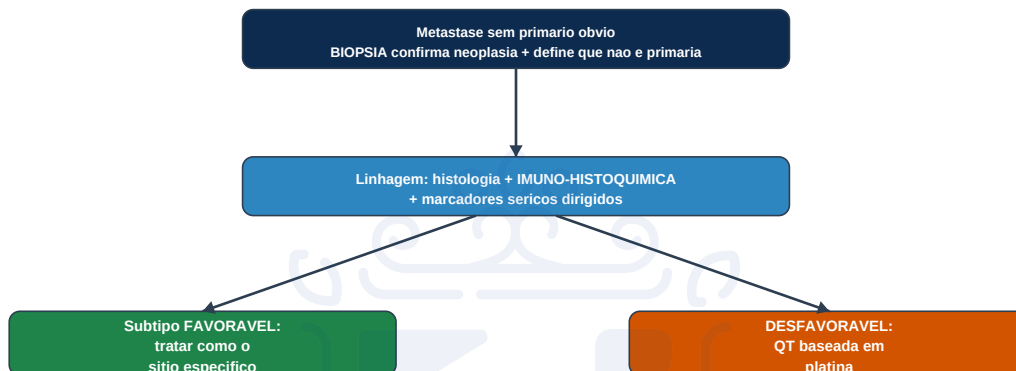


NEOPLASIA DE SÍTIO PRIMÁRIO INDETERMINADO

FLUXOGRAMA — INVESTIGAÇÃO

CSPD — BIÓPSIA -> IMUNO-HISTOQUÍMICA -> SUBTIPO



DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA

O QUE É

- Neoplasia que se apresenta como METÁSTASE sem sítio primário identificado ao diagnóstico
- ~2% de todos os cânceres invasivos; incidência em queda (melhores tecnologias diagnósticas)
- Sintomas dependem do local das lesões (dor óssea, tosse...) ou achado incidental
- Alta mortalidade: sobrevida em 1 ano ~20%, metade das mortes nos primeiros 3 meses

INVESTIGAÇÃO (ESMO 2022)

PASSO A PASSO

1. BIÓPSIA confirmando que a lesão é neoplásica
2. Definir se a lesão NÃO é primária daquela região (tamanho, localização, imagem, padrão de disseminação; ausência de linfonodos próximos reduz chance de ser primária)
3. Exames básicos + história/exame dirigidos pelas hipóteses
4. Determinar a LINHAGEM por histologia + IMUNO-HISTOQUÍMICA (papel central do patologista)
5. Painéis moleculares (alvos terapêuticos) para definir tratamento

MARCADORES SÉRICOS DIRIGIDOS

Suspeita	Marcador
Células germinativas	Alfa-fetoproteína e beta-hCG
Próstata	PSA
Ginecológico	CA 125 (e CA 15-3)
Trato gastrointestinal	CA 19-9, CEA, CA 72-4
Neuroendócrino	Cromogranina A

GRUPOS HISTOLÓGICOS

4 GRUPOS (ESMO)

- Adenocarcinomas diferenciados — 50% dos casos
- Adenocarcinoma pouco diferenciado / carcinoma não diferenciado — 30%
- Carcinoma de células escamosas — 15%
- Neoplasias indiferenciadas — 5%
- NÃO são considerados CSPD: tumores neuroendócrinos (diretriz nova), sarcomas, melanomas, germinativos e hematológicos — seguem diretrizes próprias

MANEJO POR SUBTIPO

FAVORÁVEL x DESFAVORÁVEL

- Se o sítio primário for descoberto -> tratar conforme o tumor de origem
- Subtipos FAVORÁVEIS (ex.: 7 subtipos da ESMO; renal-like; CSPD localizado/oligometastático) -> terapia do sítio específico
- DESFAVORÁVEL (não se enquadra nos favoráveis): prognóstico ruim, geralmente quimioterapia baseada em PLATINA
- Painel molecular pode indicar terapia-alvo/imunoterapia
- Manejo por equipe multidisciplinar de oncologia

ABORDAGEM NO PS / ENCAMINHAMENTO

O QUE FAZER

- ☐ Tratar as urgências oncológicas associadas (hipercalcemia, compressão medular, TEV, dor)
- ☐ Documentar a apresentação (metástases, sintomas) e antecedentes
- ☐ Solicitar biópsia da lesão acessível e exames básicos
- ☐ Encaminhar à oncologia para imuno-histoquímica/painel molecular e estadiamento
- ☐ Estabelecer cuidados de suporte/paliativos conforme a gravidade

MODELO DE ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com metástase(s) em ____ sem sítio primário definido; biópsia: ____ (linhagem).
- Imuno-histoquímica/marcadores: ____; sintomas/urgências oncológicas: ____.
- Conduta: suporte + investigação (IHQ/molecular); subtipo favorável/desfavorável: ____.
- Encaminhamento à oncologia para estadiamento e definição terapêutica.

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é o primeiro passo na investigação de uma neoplasia de sítio primário desconhecido?

- A) Quimioterapia empírica imediata
- B) Biópsia confirmando que a lesão é neoplásica (e depois definir linhagem por imuno-histoquímica)
- C) Radioterapia de todo o corpo
- D) Apenas marcadores tumorais séricos
- E) Cirurgia exploradora

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o grupo histológico mais frequente no câncer de sítio primário desconhecido?

- A) Carcinoma de células escamosas
- B) Adenocarcinomas diferenciados (~50%)
- C) Neoplasias indiferenciadas
- D) Sarcomas
- E) Melanomas

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Em homem jovem com CSPD, quais marcadores séricos sugerem tumor de células germinativas?

- A) PSA
- B) Alfa-fetoproteína e beta-hCG
- C) CA 125
- D) Cromogranina A
- E) CEA isolado

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual exame é central para determinar a linhagem celular no CSPD?

- A) Tomografia de corpo inteiro
- B) Imuno-histoquímica da biópsia (com histologia)
- C) Hemograma
- D) PET-CT isolado
- E) Marcadores tumorais séricos isolados

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual o tratamento geral do CSPD de subtipo DESFAVORÁVEL?

- A) Apenas observação
- B) Quimioterapia baseada em platina (prognóstico reservado)
- C) Cirurgia curativa em todos
- D) Radioterapia exclusiva
- E) Antibioticoterapia

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O primeiro passo é a biópsia confirmando a natureza neoplásica da lesão; em seguida, determina-se a linhagem por histologia + imuno-histoquímica, orientando a busca do primário e o tratamento.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Os adenocarcinomas diferenciados são o grupo mais frequente (~50%), seguidos por adenocarcinoma pouco diferenciado/não diferenciado (30%), escamosos (15%) e indiferenciados (5%).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Alfa-fetoproteína e beta-hCG sugerem tumor de células germinativas; PSA aponta próstata; CA 125 ginecológico; CA 19-9/CEA gastrointestinal; cromogranina A neuroendócrino.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A imuno-histoquímica da biópsia (associada à morfologia histológica) é central para determinar a linhagem celular e orientar a investigação do sítio primário e o tratamento.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O subtipo desfavorável (não enquadrado nos favoráveis) tem prognóstico reservado e é geralmente tratado com quimioterapia baseada em platina; painel molecular pode indicar terapia-alvo/imunoterapia.

SM24
Suporte ao Plantão Médico